Информирано съгласие

Етични основания, способност за вземане на решение, представителство и отказ в българското право — с дванадесет казуса

Упражнение 2 · Социална медицина и медицинска етика I · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ · Медицински университет – Пловдив

План на упражнението

Блок	Казуси
1 · Понятие и етични основания	—
2 · Информация, форма и обхват	1–4 (с цялата група)
3 · Способност, деца и представителство	5–8 (с цялата група)
4 · Отказ, спешност, лечение против волята	9–12 (в малки групи)
5 · Практика: документиране и отговорност	—

Как работим

- всеки казус: факти → въпроси → вашето решение → **ключови моменти**
- винаги питаме: **кой решава, въз основа на каква информация, доколко свободно, за коя намеса и по кой член?**
- отправна точка е българското право; чуждите правила са отбелязани като *сравнителни*

СЪДЪРЖАНИЕ

1. **Понятие и етични основания**
2. Информация, форма и обхват
3. Способност, деца и представителство
4. Отказ, спешност и лечение против волята
5. Практика: документиране и отговорност

Какво е информираното съгласие

Информираното съгласие е доброволното решение на лице, способно да вземе решение, да приеме конкретна медицинска намеса, след като е получило и разбрало информация за нейното естество, цел, ползи, рискове и алтернативи. То е **процес на общуване**, а не подпис.

> *Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.*
>
> — Закон за здравето, чл. 87, ал. 1

> *Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. ... Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.*
>
> — Конвенция за правата на човека и биомедицината, чл. 5

Ориентири: Schloendorff v. Society of New York Hospital (САЩ, 1914) — самоопределение по отношение на собственото тяло · Нюрнбергски кодекс (1947) — доброволно съгласие в изследванията · Salgo v. Leland Stanford (САЩ, 1957) — терминът „информирано съгласие“ · Конвенцията от Овиедо (1997) — задължителен договор; за България в сила от 01.08.2003 г.

Защо съгласието е важно: четири етични основания

Автономност

човекът решава какво се случва с тялото и живота му — дори когато изборът се различава от препоръката на лекаря

Благо на пациента

само пациентът може да прецени как ползата или рискът се вписват в ценностите, работата, семейството и страховете му

Доверие

честното общуване без натиск поддържа доверието и откровеността, от които зависи добрата грижа

Достойнство и неприкосновеност

докосване или операция без разрешение превръща човека в обект — само в средство

Патернализъм

лекарят решава „за доброто на пациента“. **Меки-ят** патернализъм защитава човек, чийто избор не е автономен; **твърдият** отменя автономен избор — днес почти никога не е оправдан.

Споделено вземане на решение

лекарят носи доказателствата, възможностите и несигурността; пациентът — целите и ценностите си. **Съгласието разрешава** предложена намеса; то не задължава лекаря да извърши клинично неподходящо лечение.

Пет елемента на валидното съгласие

Елемент	Практически въпрос	Признак за недостатък
Достатъчна информация	Знае ли пациентът какво се предлага, защо се предлага и какви са реалистичните алтернативи?	решението се основава на съществено пропуснат или изопачен факт
Разбиране	Може ли пациентът със свои думи да обясни основната полза, риск и последица от отказа?	повтаря формулировки от бланката, без да схваща значението им за себе си
Способност за решение	Може ли да оцени информацията спрямо собственото си положение и да изрази избор?	остър когнитивен или психичен проблем нарушава преценката по конкретния въпрос
Доброволност	Има ли реална възможност да приеме или откаже без заплаха и неправомерен натиск?	страх, зависимост, измама или манипулация
Конкретно волеизявление	За коя дейност, в какъв обем и при какви условия?	общ подпис се използва като разрешение за непредвидени или различни намеси

Учебник по медицинска етика, гл. 6 (таблица „Елементи на валидното информирано съгласие“)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Понятие и етични основания
2. **Информация, форма и обхват**
3. Способност, деца и представителство
4. Отказ, спешност и лечение против волята
5. Практика: документиране и отговорност

Какво трябва да обясни лекуващият лекар

За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, ... относно:

1. *диагнозата и характера на заболяването;*
2. *описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;*
3. *потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;*
4. *вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.*

— Закон за здравето, чл. 88, ал. 1 (съкратено)

Медицинската информация по ал. 1 се предоставя ... своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение.

— Закон за здравето, чл. 88, ал. 2 (съкратено)

Сравнително: колко да се разкрие?

професионален стандарт (какво обикновено казват лекарите) · стандарт на *разумния пациент* (какво би искал да знае разумен човек) · *субективен* стандарт (какво е нужно на този пациент). Обединеното кралство: Montgomery v Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11 — съществени рискове.

Писмена форма и правото да не знаеш

> *При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма.*
>
> — Закон за здравето, чл. 89, ал. 1

Бланката документира разговора; тя не го замества.

Форми на съгласие: **изрично** (устно или писмено) или **мълчаливо**, с конклудентни действия, при прости нискорискови действия (съдействие при измерване на кръвното налягане след обяснение); мълчанието или липсата на съпротива не са съгласие. Приемането в болница не е общо съгласие; правомощието при спешност по чл. 89, ал. 2 не е „мълчаливо съгласие“.

Закон за здравето, чл. 92: лекуващият лекар информира пациента за здравословното му състояние, заболяването и прогнозата, планираните дейности и рисковете, алтернативите, както и за **името, длъжността и специалността** на участващите в диагностично-лечебния процес.

- Пациентът може да **откаже** да бъде информиран за заболяването, прогнозата и планираните дейности — освен когато състоянието му застрашава здравето на други лица (чл. 92, ал. 2); решението **се отразява писмено** (ал. 3).
- Той може да упълномощи **писмено** лице, което да бъде информирано вместо него (ал. 4) — това лице получава информация, но не решава вместо пациента.

Обхват на съгласието и проверка на разбирането

Обхват

- съгласието разрешава **определена** намеса — не „каквото се наложи“;
- **предвидимите разширения** (напр. преминаване към отворена операция) се обсъждат и записват предварително;
- съществено различна намеса изисква ново информиране и съгласие — писмено, когато го изисква чл. 89, ал. 1;
- съгласието може да бъде **оттеглено във всеки момент** (Конвенция от Овиедо, чл. 5); започнатата дейност се спира или променя по безопасен начин и последиците се разясняват.

Разбиране

- ясен език и естествени честоти с еднакъв знаменател: риск, който спада от 6 на 3 на 100, е **абсолютно** намаление с 3 процентни пункта и **относително** с 50% (хипотетично);
- „Обяснете ми със свои думи какво ще направим и какво може да се обърка“ — проверява обяснението на лекаря, не пациента;
- време, преводач, писмени материали, близък човек по избор на пациента.

Съгласието не е отказ от права

Разяснено усложнение на правилно показана и компетентно извършена намеса само по себе си не доказва небрежност; разясняването никога не оправдава небрежност, нарушение на стандартите или прикрита грешка.

Казус 1 · Услужливата сестра

Казусът

Хирург, зает с други пациенти, се обажда на медицинската сестра в отделението и я моли да „вземе писменото съгласие“ за утрешната операция. Сестрата подава формуляра на пациента, който го подписва, без да го прочете. След операцията се развива инфекция на оперативната рана — усложнение, описано във формуляра, но за което лекуващият лекар не е информирал пациента. Пациентът подава жалба, че не е бил информиран.

1. Основателна ли е жалбата?
2. Може ли сестрата да вземе съгласието? Каква е била правилната ѝ роля?
3. Какво доказва подписът — и какво не доказва?

Казус 1 · Услужливата сестра — ключови моменти

Право

- Задължението да информира е на **лекуващия лекар** (Закон за здравето, чл. 88, ал. 1); при операция информацията и съгласието са **писмени** (чл. 89, ал. 1).
- Подпис без разяснение доказва, че е подписан формуляр, а не че пациентът е **информиран** — жалбата за информирането е основателна.
- Жалба може да се подаде до РЗИ (чл. 93), а за етично нарушение — до районната колегия на БЛС.

Етика и практика

- Сестрата може да **подпомага** процеса — да предаде формуляра, да отговори на практически въпроси, да съобщи на лекаря, че пациентът има въпроси, — но не замества разговора с лекаря.
- Инфекцията сама по себе си не доказва вина: известно усложнение на правилно извършена операция не означава небрежност; проблемът тук е липсващото разяснение.
- Правилно: хирургът (или лекар от екипа) разяснява преди операцията; сестрата отказва да „събира подписи“ сама.

Казус 2 · Неспоменатата алтернатива

Казусът

На мъж с новодиагностицирана хронична миелоидна левкемия в хронична фаза е предложена алогенна трансплантация на стволови клетки; той е напълно информиран за рисковете ѝ, включително реакцията „присадка срещу приемник“. След трансплантацията реакцията се развива тежко. Тогава той научава, че тирозинкиназните инхибитори (напр. иматиниб) са стандартното лечение на първа линия, овладяват заболяването при повечето пациенти, а при подбрани пациенти с трайен дълбок молекулен отговор позволяват планирано спиране на лечението под молекулно наблюдение — а трансплантация обикновено се прилага при заболяване, неовладяно от тях. Никой не му го е казал. Той подава жалба.

1. Информирано ли е било съгласието му, макар всички рискове на трансплантацията да са разяснени?
2. Коя точка на чл. 88, ал. 1 от Закона за здравето е нарушена?
3. Защо изобщо е предложена трансплантация? Какво трябва да докаже пациентът, за да получи обезщетение?

Казус 2 · Неспоменатата алтернатива — ключови моменти

Право

- Чл. 88, ал. 1, т. 2 изисква информация за **разумните алтернативи**; стандартното лечение на първа линия очевидно е такава. Съгласието **не е информирано**.
- Разясняването на всички рискове на един вариант не поправя пропускането на друг; отделен въпрос е дали предложението изобщо е клинично обосновано.
- За обезщетение пациентът трябва да докаже и вреда, и причинна връзка с нарушението (Закон за задълженията и договорите — договорна или деликтна отговорност; упражнение 4).

Етика

- Вариантите се различават по полза, тежест, несигурност и шанс за ремисия без лечение; претеглянето им е ценностен избор на пациента.
- Да се пропусне алтернатива, защото лекарят предпочита другия вариант, е скрит патернализъм.
- Добра практика: вариантите се представят един до друг — полза, риск, тежест, несигурност — и се записва кои са обсъдени.

Казус 3 · Информираният риск

Казусът

Мъж се нуждае от реваскуларизация на коронарна артерия. Обяснено му е, че ангиопластиката носи малък риск от разкъсване на съда и фатален кръвоизлив и че алтернатива е байпас операцията. Той разбира, задава въпроси и писмено избира ангиопластика. Процедурата е извършена според добрата практика, но артерията се разкъсва и той почива. Семейството подава жалба, че „изобщо не е трябвало да му се позволи да поеме този риск“.

1. Нарушени ли са правилата за съгласие?
2. Какво е приел пациентът със съгласието си — и какво не?
3. Кога изходът от жалбата би бил различен?

Казус 3 · Информираният риск — ключови моменти

Право

- При условие че са обсъдени и очакваната полза, прогнозата и компромисите на алтернативата (чл. 88, ал. 1, т. 2–4), формата е писмена (чл. 89, ал. 1) и изборът е доброволен, **съгласието е валидно**.
- Осъщественият риск е **разяснен и приет**; усложнението само по себе си не доказва нарушение.
- Изходът е различен, ако процедурата е **извършена небрежно**: съгласието никога не покрива небрежност.

Етика

- Уважението към автономността включва правото да приемеш риск, който семейството не би приело.
- Скръбта на семейството изисква време и честно обяснение какво се е случило (разкриване след нежелано събитие).
- Документираният разговор защитава както избора на пациента, така и екипа.

Казус 4 · Решения под упойка

Казусът

40-годишен мъж подписва писмено съгласие за премахване на полипи в носната кухина. По време на операцията хирурзите откриват съмнителна лезия на носна конха; експресното хистологично изследване показва ранен карцином. Премахването на конхата може да се окаже подходящо лечение, но стадият и окончателният план изискват допълнително уточняване. Ако се извърши веднага, ще му бъде спестена втора обща анестезия; съпругата му чака пред операционната.

1. Могат ли хирурзите да разширят операцията без ново съгласие?
2. Може ли съпругата да даде съгласие вместо него?
3. Как би могла да се предотврати тази дилема?

Казус 4 · Решения под упойка — ключови моменти

Право

- Съгласието обхваща **само полипектомията**. Чл. 89, ал. 2 допуска намеса без писмено съгласие само когато **непосредствено е застрашен животът** — ранният карцином не е спешност.
- Съпругата **няма законово правомощие** да дава информирано съгласие за пълнолетен, който след часове ще може да реши сам (чл. 87 изброява лицата, които дават съгласие; съпругът не е сред тях). Формулировката „близките“ в чл. 26 от Кодекса не създава представителна власт.
- Правилно: полипектомията се завършва; уточняването и планът на лечение могат безопасно да изчакат; пациентът се информира и дава ново писмено съгласие.

Етика и превенция

- „Спестяването на втора упойка“ е реална полза, но претеглянето ѝ е право на **пациента**.
- Превенция: преди операцията се обсъждат **предвидимите находки** и се записва какво разрешава пациентът („ако се открие тумор, съгласен съм / не съм съгласен ...“).
- Кодекс за професионална етика, чл. 26: без процедури без съгласие освен при непосредствена заплаха за живота.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Понятие и етични основания
2. Информация, форма и обхват
3. **Способност, деца и представителство**
4. Отказ, спешност и лечение против волята
5. Практика: документиране и отговорност

Две различни понятия: дееспособност и способност за вземане на решение

Дееспособност — правен статус

Закон за лицата и семейството (различна от **правоспособността** — способността да бъдеш носител на права и задължения, от раждането, т. 1):

- ненавършили 14 г. — **малолетни**: действат чрез родител или настойник (т. 3);
- от 14 до 18 г. — **непълнолетни**: действат със съгласието на родител или попечител (т. 4);
- от 18 г. — **пълнолетни**, напълно дееспособни (т. 2);
- **запрещение**, пълно или ограничено, само със съдебно решение (т. 5).

Способност за вземане на решение — клинична преценка

За **това решение, в този момент**. Диагнозата, възрастта, ниското образование, необичайният избор или несъгласието с лекаря **не доказват** сами по себе си неспособност. Способността може временно да се загуби (делир, хипоксия, седация) и да се **възстанови**.

Формално дееспособен пълнолетен може временно да не е способен да реши; човек с психиатрична диагноза може да е напълно способен. Медицината преценява способността; запрещението и отмяната му стават по съдебен ред; диагнозата сама по себе си не променя дееспособността.

Оценка на способността за вземане на решение

Разбиране

може ли да каже със свои думи какво се предлага и защо?

Оценка за себе си

разпознава ли как състоянието и възможностите могат да засегнат **него**?

Разсъждение

може ли да сравни възможностите и последиците в съгласие със своите ценности?

Изразяване на избор

може ли да съобщи избор? Изяснете колебанията и противоречията

Пропорционалност: колкото по-сериозни и необратими са последиците, толкова по-внимателно се установява способността — но отказът сам по себе си не е доказателство за неспособност.

Клинична рамка: Appelbaum PS, Grisso T. N Engl J Med 1988;319:1635–1638. doi:10.1056/NEJM198812223192504. Затрудненото говорене или афазията сами по себе си не означават неспособност — осигурете алтернативна комуникация. В българското право тя насочва преценката на лекаря; не е отделен законов тест.

Първо направете решението възможно

овладейте болката и делира; слухов апарат, очила, преводач; спокойна обстановка и време; разделете сложната информация; повторете по-късно; привлечете близък човек по избор на пациента; при съмнение — консултация с психиатър.

Кой дава съгласие? Закон за здравето, чл. 87

Положение	Кой дава съгласие
Пълнолетен, способен да реши	само пациентът (чл. 87, ал. 1) — близките **нямат** право на вето
Непълнолетен (14–18 г.); лице под ограничено запрещение	пациентът **и** родител или попечител (ал. 2)
От 16 г.: консултации, профилактични прегледи и изследвания по Наредба № 8/2018	само непълнолетният (ал. 3)
Малолетен; недееспособен	родител или настойник, освен в предвидените със закон случаи (ал. 4)
Дете, настанено извън семейството по съдебен ред	ако съгласието на родител или настойник не може да бъде получено своевременно — лицето, на което са възложени грижите, след положително становище на дирекция „Социално подпомагане“ (ал. 5)
Дете, настанено временно по административен ред	дирекция „Социално подпомагане“ (ал. 6)
Психично разстройство с установена от съда неспособност	лицето, определено от съда в производството за задължително лечение (ал. 7, чл. 162, ал. 3) — специален ред, а не общ ред за всеки неспособен да решава пълнолетен; при високорискови дейности — и разрешение на комисията по медицинска етика, а при липса на комисия — на ръководителя, и съгласие на законните представители (чл. 89, ал. 3)

Близкият на пълнолетен не е законен представител: той разказва на екипа за ценностите на пациента, но не дава съгласие вместо него. Който и да дава съгласие, пациентът участва, доколкото позволява способността му (Конвенция от Овиедо, чл. 6).

Навършили 16, но ненавършили 18 г.: какво могат да решат сами

Наредба № 8 от 27.06.2018 г. (на основание чл. 87, ал. 3 от Закона за здравето) — без съгласие на родител от 16 г.:

- **консултиране** (чл. 2): поведенчески здравен риск, психично здраве, **сексуално и репродуктивно здраве**, дентално здраве, здравна култура;
- **профилактични прегледи** (чл. 3), вкл. дентален и профилактичен преглед при специалист;
- **изследвания** (чл. 4): ХИВ, сифилис, гонорея, хламидийна инфекция, профилактично изследване на кръв и урина, **изследване за бременност**.

> *В случай на установяване на отклонения от здравословното състояние/заболяване в хода на провежданите здравни консултации, прегледи и/или изследвания лекарят, установил отклонението, задължително и своевременно уведомява родителя или попечителя на лицето.*
>
> — Наредба № 8/2018, чл. 5

Извън Наредбата

Лечение, предписване и инвазивни процедури при непълнолетен изискват **и** неговото съгласие, **и** съгласието на родител (чл. 87, ал. 2). От 22.12.2023 г. брак може да сключи само лице, навършило 18 години (Семеен кодекс, чл. 6, ал. 1).

Казус 5 · Родителите ги няма

Казусът

По време на игра в училищния двор 10-годишно момче преминава през счупен прозорец и получава тежко разкъсване на лъчевата артерия. Учителката веднага го отвежда в спешното отделение. Детето кърви обилно и се нуждае от кръвопреливане и спешна съдова операция. Родителите не могат да бъдат открити по телефона.

1. Необходимо ли е информирано съгласие — и от кого?
2. Може ли учителката да подпише съгласието?
3. Какво трябва да направи екипът по време на операцията и какво да документира?

Казус 5 · Родителите ги няма — ключови моменти

Право

- За малолетен съгласие дава родителят (чл. 87, ал. 4); при операция се изисква писмена форма (чл. 89, ал. 1).
- Чл. 89, ал. 2 и Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, чл. 32, ал. 1: когато **животът е застрашен** и съгласието на родителя **не може да бъде получено своевременно**, намесата и кръвопреливането се извършват без съгласие; решението и мотивите се записват (чл. 32, ал. 2).
- Учителката **не е** законен представител; подписът ѝ няма правно значение.

Практика

- Операцията не се отлага, за да се търсят родителите — но опитите да се свържат с тях продължават успоредно.
- Документира се: заплахата за живота, опитите за връзка с родителите, часът, кой е решил.
- Родителите се информират възможно най-скоро; на момчето се обяснява според възрастта какво се случва.

Казус 6 · Консултация на шестнадесет

Казусът

16-годишно момиче идва само при гинеколог за профилактичен преглед и иска информация за видовете контрацепция. Накрая пита дали може още днес да ѝ бъде поставено вътрематочно средство и дали родителите ѝ „ще разберат“. Тя е здрава; няма спешност.

1. Може ли лекарят да я прегледа и консултира без родител?
2. Подчиняват ли се разговорът и поставянето на спиралата на едно и също правило?
3. Какво може да се обещае за поверителността — и какво не?

Казус 6 · Консултация на шестнадесет — ключови моменти

Право

- От 16 г. **профилактичният преглед** и **консултирането по сексуално и репродуктивно здраве** не изискват съгласие на родител (чл. 87, ал. 3; Наредба № 8/2018, чл. 2–3); включено е и изследването за бременност (чл. 4).
- Поставянето на вътрематочно средство е **медицинска намеса** извън Наредбата: необходими са нейното съгласие **и** съгласието на родител (чл. 87, ал. 2).
- При установено заболяване или отклонение лекарят уведомява родителя (Наредбата, чл. 5).

Етика и общуване

- **Границите** на поверителността се обясняват в началото — не се обещава абсолютна тайна.
- Предложете подкрепа за разговор с родител; дайте точна информация за методите, включително за презерватива като защита от инфекции.
- Проверете тактично дали връзката е доброволна и без експлоатация (Закон за закрила на детето, чл. 7: задължение за сигнал при дете в риск).

Казус 7 · Почти пълнолетен

Казусът

М., на 17 години, е прегледан от уролог по повод фимоза. Той иска да му бъде извършена циркумцизия (обрязване), но без знанието на родителите си, защото се срамува. Процедурата е сравнително лесна и може да се направи с местна упойка. След пет месеца той навършва 18 години.

1. Може ли урологът да извърши процедурата само със съгласието на момчето?
2. Има ли значение, че намесата е малка и момчето е почти пълнолетно?
3. Как урологът да зачете желанието му за поверителност?

Казус 7 · Почти пълнолетен — ключови моменти

Право

- Циркумцизията е хирургична намеса, а не консултиране или профилактичен преглед — Наредба № 8/2018 не се прилага.
- На 17 г. са необходими съгласието на момчето **и** на родител (чл. 87, ал. 2); при операция — писмена форма (чл. 89, ал. 1).
- Няма спешност: чл. 89, ал. 2 е неприложим. Навършването на 18 г. е твърда правна граница, а не въпрос на степен.

Етика и общуване

- Неговото съгласие е **законово необходимо**, а не просто „одобрение“ — той решава заедно с родителя.
- Възможности: помогнете му да говори с родител; оставете го да избере кой родител; или отложете планираната процедура до 18 г., ако това е медицински безопасно.
- Самият преглед и консултацията са поверителни в рамките на закона.

Казус 8 · Момичето, което живее с приятеля си

Казусът

Р., на 17 години, живее от шест месеца в Пловдив с 22-годишния си приятел след религиозна церемония; граждански брак няма. Тя е напипала бучка в лявата си гърда и иска преглед и премахване на формацията. Не поддържа връзка с родителите си, които работят в чужбина. Приятелят ѝ казва, че ще „подпише всичко“.

1. Какво може да направи лекарят само с нейното съгласие?
2. Може ли приятелят да даде съгласие? Би ли променил нещо граждански брак?
3. Какво трябва да се направи, за да се стигне до родителите, и има ли основание за закрила на детето?

Казус 8 · Момичето, което живее с приятеля си — ключови моменти

Право

- Консултирането по Наредба № 8/2018 може да се проведе. Диагностичното уточняване на **симптоматична** бучка изисква нейното съгласие **и** на родител (чл. 87, ал. 2); за инвазивните стъпки — биопсия, операция — информацията и съгласието са писмени (чл. 89, ал. 1).
- Приятелят **няма правна роля**; от 22.12.2023 г. брак под 18 години е невъзможен (Семеен кодекс, чл. 6, ал. 1).
- Няма спешност: потърсете родителите; телефонният разговор подпомага общуването, но се проверяват самоличността и родителското качество и за инвазивните намеси се получава и съхранява писмено съгласие.

Етика и закрила

- Уважение към автономността и достойнството ѝ — без предразсъдъци въз основа на етнос или начин на живот.
- Преценете **безопасността**: разлика във възрастта, откъсване от семейството, зависимост. Ако тя е в риск, лекарят е длъжен да уведоми дирекция „Социално подпомагане“ или полицията (Закон за закрила на детето, чл. 7, ал. 2), дори и да е обвързан с професионална тайна.
- Ако родителите са недостъпни, дирекция „Социално подпомагане“ може да помогне за законосъобразно съгласие.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Понятие и етични основания
2. Информация, форма и обхват
3. Способност, деца и представителство
4. **Отказ, спешност и лечение против волята**
5. Практика: документиране и отговорност

Информиран отказ

> *Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, ... може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.*
>
> — Закон за здравето, чл. 90, ал. 1 (съкратено)

- отказът се удостоверява в медицинската документация **с подписи** (ал. 2);
- ако лицето не е в състояние или откаже да го удостовери писмено — **с подпис на лекуващия лекар и на свидетел** (ал. 3);
- пациентът може да **оттегли отказа си по всяко време**; медицинските специалисти не носят отговорност за евентуалното забавяне (ал. 5).

> *Когато болният поради непознаване на опасните последици на заболяването отказва съгласие за необходими изследвания и лечение (например операция), лекарят е длъжен да разясни и неблагоприятната прогноза, ако не се проведе това лечение, по разбираем за пациента начин. Това задължение отпада, когато пациентът изрично заяви, че не желае да получи тази информация.*
>
> — Кодекс за професионална етика на лекарите, чл. 29

Отказът прекратява една намеса, не лекарската грижа: алтернативите, палиативната грижа и отворената врата остават.

Две различни правни положения: чл. 89, ал. 2 и чл. 90, ал. 4

Чл. 89, ал. 2 — съгласие не може да бъде получено	**Чл. 90, ал. 4 — съгласието е отказано**
непосредствено е застрашен животът **и** физическото или психичното състояние не позволява изразяване на съгласие	пациентът (или представителят) е **отказал** и животът на пациента е застрашен
и съгласието на изисквания от закона представител не може да бъде получено **своевременно**	**ръководителят на лечебното заведение** може да вземе решение за животоспасяващо лечение
екипът действа в полза на здравето на пациента без писмено съгласие	преценка на определено лице — **не** автоматично правомощие на всеки лекар
типично: пострадал в безсъзнание, дете, чиито родители не могат да бъдат открити	типично: отказ от кръвопреливане; родители, отказващи лечение на детето си

Разграничавайте отказа на родител, установения автономен отказ на пълнолетен и съмнението в способността или в приложимостта на отказа. Чл. 90, ал. 4 се тълкува заедно с Конституцията, чл. 52, ал. 4, и Конвенцията от Овиедо, чл. 5. При кръвопреливане специалният Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането урежда съгласието (чл. 31), спешността (чл. 32) и отказа по всяко време (чл. 33), без да предвижда преодоляването на отказа — съотношението с чл. 90, ал. 4 е въпрос на тълкуване (общ и специален закон). ЕСПЧ, Pindo Mulla v. Spain [GC], № 15541/20, 17.09.2024 г. — тълкуване на Конвенцията, обвързващо и България: нарушение на чл. 8 във връзка с чл. 9; трябва да се установи дали отказът е свободен, информиран, конкретен, актуален и приложим.

Лечение против волята и предварително изразени желания

> *Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон.*
>
> — Закон за здравето, чл. 91

> *Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.*
>
> — Конституция на Република България, чл. 52, ал. 4

Примери в Закона за здравето: **задължителна изолация** при изброени заразни болести (чл. 61); **спешна психиатрична помощ** при пряка и непосредствена опасност (чл. 153); временно настаняване след овладяване на спешното състояние до 24 часа, удължимо еднократно с до 48 часа с разрешение на районния съдия (чл. 154); **задължително настаняване и лечение** само със **съдебно решение** за лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, опасно за близките или околните, или застрашават сериозно здравето си (чл. 155–156). Задължителната изолация не е общо разрешение за всяко лечение против волята.

> *Желанията във връзка с медицинска интервенция, предварително изразени от пациент, неспособен в момента на интервенцията да изрази волята си, се вземат предвид.*
>
> — Конвенция за правата на човека и биомедицината, чл. 9

На практика

В българското право няма общ закон за предварителните разпореждания. По-рано изразените желания — устни или писмени, предадени от близки или отразени в документацията — са **доказателство за ценностите на пациента**, които трябва да се вземат предвид. Разграничавайте общото предпочитание от конкретен приложим отказ.

Работа в малки групи: казуси 9–12

Задача — 6 минути

За вашия казус отговорете:

1. Способен ли е пациентът да вземе решение? Как разбирате това?
2. Кой решава — и на основание на кой член?
3. Чл. 89, ал. 2, чл. 90, ал. 4 или нито един от тях?
4. Какво ще направите **сега** и какво ще документирате?

Доклад — по 2 минути

- Група 1: Казус 9 · Срещу волята на родителите
- Група 2: Казус 10 · Ветеранът
- Група 3: Казус 11 · „Оставете ме без лекари“
- Група 4: Казус 12 · Кой да реши?

Казус 9 · Срещу волята на родителите

Казусът

И., на 10 години, е приет в хематологично отделение по повод тежка анемия; състоянието му е тежко и той се нуждае от кръвопреливане. Родителите му са Свидетели на Йехова и категорично отказват: искат да подпишат отказ и заявяват, че за тях преливането е по-лошо дори от смъртта на сина им. Алтернативите са опитани без достатъчен ефект.

1. Може ли отказът на родителите да бъде зачетен, когато застрашава живота на детето?
2. Кой решава в болницата и на какво правно основание?
3. Какво задължение възниква по закона за закрила на детето?

Казус 9 · Срещу волята на родителите — ключови моменти

Право

- За малолетен съгласие дават родителите (чл. 87, ал. 4) и те могат да откажат (чл. 90, ал. 1); отказът се удостоверява (чл. 90, ал. 2–3).
- Когато **животът на детето е застрашен**, **ръководителят на лечебното заведение** може да вземе решение за животоспасяващо лечение (чл. 90, ал. 4); специалният Закон за кръвта (чл. 31–33) урежда съгласието и отказа от родителя като законен представител. Решението се документира и се взема навреме; влошаването само по себе си не отменя отказа.
- Дете в риск: задължение за сигнал до дирекция „Социално подпомагане“ (Закон за закрила на детето, чл. 7).

Етика

- Родителските права се упражняват в интерес на **детето**; родителите могат да откажат за себе си това, което не могат да откажат за детето си.
- Уважение към семейството: всички безкръвни алтернативи, обяснение, участие на представител, поискан от семейството, родителите остават при детето.
- Пълнолетен $\neq$ дете: пълнолетен, способен да реши, може да откаже за себе си (вж. примера от упражнение 1).

Казус 10 · Ветеранът

Казусът

Г-н Т., на 84 години, ветеран от българската армия без живи роднини, живее в дом за грижи. Физически е немощен и има лек когнитивен упадък. Развива гангрена на ходилото с нарастващи признаци на системна инфекция, която не се повлиява от лечението; без ампутация в следващите дни се очаква сепсис с висок риск от смърт. Той отказва: „Кракът ми сам ще се оправи. В армията съм виждал много по-лоши неща!“

1. Означава ли лекият когнитивен упадък, че той не е способен да реши?
2. Какво точно трябва да се оцени — и „погрешна“ ли е причината му?
3. Ако не е способен, кой може да реши, след като няма близки?

Казус 10 · Ветеранът — ключови моменти

Оценка

- Диагнозата и възрастта **не доказват** неспособност. Оценете четирите способности за **това** решение.
- „Сам ще се оправи“ може да е **неспособност да оцени** фактите (проблем със способността) — или ценностен избор („няма да живея без крака си“). Изяснете кое: обяснете отново, покажете раната, попитайте какво е важно за него.
- Лекувайте обратимите фактори (инфекция, делир, болка); консултация с психиатър или гериатър.

Кой решава

- **Ако е способен:** информиран отказ (чл. 90, ал. 1–3); палиативната грижа и отворената врата остават. Тъй като животът е застрашен, възниква и правомощието на ръководителя по чл. 90, ал. 4 — вж. напрежението на слайда за чл. 89, ал. 2 и чл. 90, ал. 4.
- **Ако не е способен:** той няма представител; подкрепете възстановяването на способността; при спешно животозастрашаващо влошаване конкретното правно основание се установява и документира; за неспешни решения — правна консултация за представителството.
- Никога не ампутирайте само защото отказът изглежда неразумен.

Казус 11 · Оставете ме без лекари

Казусът

68-годишен мъж прави опит за самоубийство, като нарочно се блъска с колата си в стълб. Постъпва с множество травми и вътрешен кръвоизлив. В спешното отделение отказва операцията, необходима за спиране на кървенето: „Искам да умра.“ Предлага да подпише отказ.

1. Автономен ли е този отказ, който трябва да бъде зачетен?
2. Способен ли е да вземе решение в този момент?
3. Какво трябва да направи екипът — и на какво правно основание?

Казус 11 · Оставете ме без лекари — ключови моменти

Оценка

- Суицидното намерение поражда **спешно съмнение** за способността и доброволността — но само по себе си не доказва неспособност.
- Оценете бързо как психично разстройство, интоксикация, черепна травма, шок и кръвозагуба влияят на **това** решение; документирайте.
- Ако се установи нарушена автономност, защитата му е **мек патернализъм**, а не отмяна на автономен избор.

Правен път

- Отказ + застрашен живот ⟶ **ръководителят на лечебното заведение** може да вземе решение за животоспасяваща операция (чл. 90, ал. 4); загубата на съзнание сама по себе си не отменя отказа.
- Психиатрична помощ: спешна психиатрична помощ (чл. 153), временно настаняване след спешното състояние (чл. 154), задължително лечение само от съда по критериите на чл. 155 — нито едно от тях само по себе си не разрешава операцията.
- Документирайте отказа (чл. 90, ал. 2–3), оценката на способността и кой е решил.

Казус 12 · Кой да реши?

Казусът

45-годишен мъж е в кома в интензивно отделение след катастрофа, с тежка травма на бедрото. Възможностите са две: ампутация с по-висока вероятност за оцеляване, но със загуба на крайника и последващи функционални ограничения, или сложна реконструкция с по-висок риск от смърт, но с шанс да запази крака. Отлагането на решението с повече от няколко часа също увеличава риска. Родителите му искат ампутация; съпругата му иска „да се направи всичко възможно кракът да бъде спасен“ и твърди, че го познава по-добре.

1. Кой има законовото право да реши за пълнолетен в безсъзнание?
2. Каква тежест имат мненията на близките?
3. Как екипът да стигне до решението и как да го документира?

Казус 12 · Кой да реши? — ключови моменти

Право

- Пълнолетен, който не е поставен под запрещение, **няма законен представител**; нито съпругата, нито родителите могат да дадат съгласие вместо него (чл. 87).
- При непосредствено застрашен живот и невъзможност пациентът да изрази съгласие екипът решава в полза на здравето му (чл. 89, ал. 2); ако има време, необратимият избор се отлага.
- Конвенция от Овиедо, чл. 9: **предварително изразените му желания** се вземат предвид.

Етика и процедура

- Близките са **свидетели на неговите ценности**, а не вземащи решение; правното основание се установява отделно от етичната преценка: какво би искал **той** — работа, спорт, отношение към инвалидността и риска?
- Медицинска преценка на риска и ползата; **лекарски консилиум** (Кодекс, чл. 38) подпомага преценката, но не създава право на съгласие; прозрачност към двете страни на семейството.
- Документират се мотивите, събраната информация за желанията му и кой е участвал.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Понятие и етични основания
2. Информация, форма и обхват
3. Способност, деца и представителство
4. Отказ, спешност и лечение против волята
5. **Практика: документиране и отговорност**

Документиране, отговорност и изследвания

Какво трябва да показва документацията

- какво е предложено; ползи, рискове, алтернативи, последици от отказа;
- каква подкрепа е осигурена (преводач, време, помощни средства) и как е проверено разбирането;
- какво е избрал пациентът и с какви ограничения; кой е присъствал; дата;
- оценката на способността, когато е имало съмнение.

Съгласието се преразглежда, когато

- намесата или обхватът ѝ се променят;
- появи се нова информация за рисковете или алтернативите;
- състоянието, способността или предпочитанията на пациента се променят;
- е минало дълго време до планирана намеса.

Отговорност

Задължението да информира е на лекуващия лекар; екипът го подпомага. Съгласието никога не покрива небрежност.

Лечението не е изследване

Медицинските опити изискват доброволно **писмено** съгласие (Конституция, чл. 29, ал. 2; Закон за здравето, чл. 199, ал. 1); етичният преглед и режимите на изследванията — упражнение 6.

Обобщение

Етика

1. Съгласието е **процес**: информация, разбиране, способност, доброволност, конкретно решение.
2. Способността за вземане на решение е функционална и се отнася до конкретно решение; дееспособността е правен статус — диагнозата не я променя, запрещението става по съдебен ред.
3. Отказът заслужава същата грижа като съгласието: разясняване, документиране, отворена врата.

Българско право

1. Съдържание: Закон за здравето, чл. 88; писмена форма: чл. 89, ал. 1; право да не знаеш: чл. 92, ал. 2.
2. Кой дава съгласие: чл. 87 — непълнолетните решават заедно с родител; от 16 г. дейностите по Наредба № 8/2018 — сами.
3. Чл. 89, ал. 2 (съгласие **не може** да бъде получено) $\neq$ чл. 90, ал. 4 (съгласието е **отказано**; ръководителят може да реши).

Преди всяка намеса: Кой решава? Разбира ли? Свободен ли е изборът? Какво точно е разрешено? Как е документирано?

Благодаря за вниманието!